신규 보건소장 직무교육 · 강의 후 배부자료

신규 보건소장을 위한

감염병 위기대응 핸드아웃

보건소장의 의사결정과 소통 — 점검표 · 양식 10종

부산광역시 사상구보건소장 이정민

2026. 11.

이 자료는 강의(110분 · 96장)를 다시 요약하지 않습니다. 부임 직후부터 위기 종료 후까지, 보건소장이 직접 판단 · 서명하는 일을 손으로 채우거나 소내 회의에서 그대로 쓰는 도구만 담았습니다.

부록 구성 쓰는 시점에 맞는 쪽을 펴십시오

부록	도구	쓰는 시점	연결 강의	쪽
1	**한 장 요약** — 준비 · 대응 · 회복 · 재준비와 여섯 질문	상시(책상 비치)	전체	2
2	**부임 후 90일 위기대비 점검표**	부임 직후	PART 2 지역 준비	3–4
3	**첫 24시간 · 72시간 행동 점검표**	위기 인지 직후	PART 3 초기대응과 결정	5–6
4	**위기단계별 보건소 업무조정 기준표**	평시 작성 · 경보 상향 시	PART 0 · 2	7–8
5	**불확실성 속 의사결정 기록지**	주요 결정마다	PART 3	9–10
6	**위기소통 문안 틀** — 첫 공지 · 브리핑 · 언론 질의	첫 공지 · 브리핑 전	PART 5 조직과 소통	11–12
7	**취약계층 · 외국인 주민 보호 점검표**	조치 결정 전후	PART 5	13
8	**종사자 보호 · 소진 관리 점검표**	대응 2주차부터 매주	PART 4 · 5	14
9	**사후검토(AAR) 진행 양식**	종료 후 가능한 조기	PART 6 회복과 재준비	15–16
10	**법령 · 지침 근거표와 참고문헌**	보고 · 결재 · 의회 대응	참고문헌(96쪽)	17
+	**용어 풀이** — 처음 접하는 용어 23개	낯선 말이 나올 때	PART 0 기초 개념	18

이럴 때 이 쪽을 펴십시오

오늘 부임했다

부록 1을 읽고, **부록 2**의 '첫 1주 다섯 가지' 중 하나를 내일 합니다.

집단발생 전화를 받았다

부록 3의 열 가지를 묻고 → **부록 5**에 결정을 적고 → **부록 6**으로 첫 공지를 냅니다.

대응이 2주를 넘겼다

부록 4로 평소 사업을 조정하고, **부록 8**로 직원 근무 · 휴식을 점검합니다.

상황이 끝났다

부록 9로 사후검토를 하고 개선과제를 예산에 올립니다.

사용 원칙 ① 빈칸에는 부서명이 아니라 **사람 이름 · 연락처 · 기한**을 적습니다. ② 시간 구분 · 주기 · 기능 배치는 교육용 예시이므로 기관 실정에 맞게 고칩니다. ③ 지침은 개정되므로 **사용 시점의 질병관리청 · 시 · 도 지침이 우선**입니다. 법정 기준이 아닌 수치 · 기한은 각 쪽에 '권고' 또는 '자체 목표'로 표시했고, 근거는 부록 10, 낯선 용어는 18쪽에서 확인합니다.

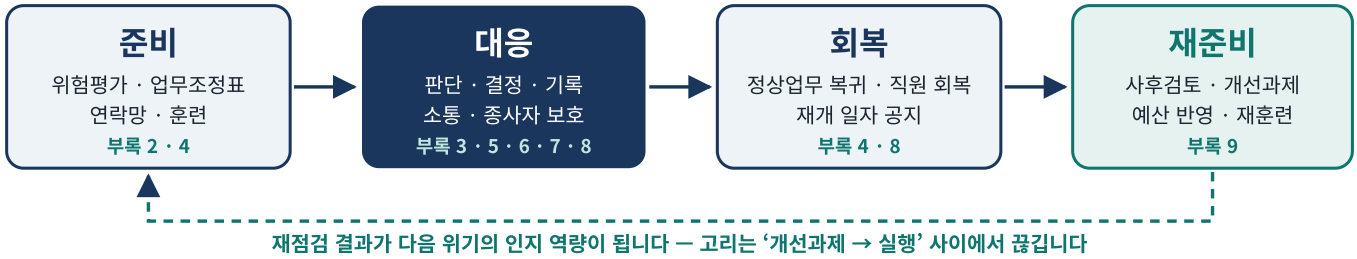
부록 1

한 장 요약 — 준비 · 대응 · 회복 · 재준비

여섯 질문을 순서대로 던지면 처음 겪는 감염병에도 같은 틀로 대응할 수 있습니다.

쓰는 시점 **상시 비치**

보건소장의 역할은 모든 문제를 직접 해결하는 것이 아닙니다. 불완전한 정보 속에서 위험을 평가하고, 적시에 판단하며, 사람과 조직을 움직이고, 그 결정에 책임지는 것입니다.



보건소장의 여섯 질문

시기	던질 질문	반드시 남길 산출물	부록
위기 전	우리 지역에서 무엇이 가장 위험한가	위험 상위 1~3개, 업무조정표, 이름이 적힌 상황실 배치표	2 · 4
위기 초기	지금 무엇을 판단하고 결정해야 하는가	시 · 도 유선보고, 첫 상황보고서, 의사결정 기록지	3 · 5
대응 현장	현장은 안전하게 일하고 있는가	근무 · 휴식이 명시된 근무편성표, 투입 직전 보호구 재교육	8
우리 조직	이 대응을 얼마나 지속할 수 있는가	주간 소진 점검 결과, 대체인력 명단, 업무조정 단계 결정	4 · 8
주민과의 관계	주민은 무엇을 알고, 믿고, 해야 하는가	4요소 최초 메시지, 단일 발표 창구, 취약계층 보완조치	6 · 7
위기 이후	이 경험을 다음 역량으로 어떻게 바꿀 것인가	담당 · 기한 · 예산이 적힌 개선과제	9

발생하면 — 초기 판단 5단계

상황실 벽에 붙여 둡니다(부록 3)

1 발생현황 확인
무엇이 · 몇 명 · 어디서 · 언제부터. 경보 수준과 주관 기관

2 지침 숙지
최신 지침의 잠복기 · 전파경로 · 격리 · 접촉자 범위

3 주의사항 검토
대변인 · 대리자 지정, 취약계층 · 시설 포함 여부

4 초기회의
9개 기능에 이름 배치, 다음 회의 시각 고정

5 업무분장
보건소 · 의료기관 · 시 · 도 · 질병관리청의 역할 확정

다섯 문장

1. **완벽한 정보를 기다리지 말라.** 불확실성은 사라지지 않고 줄어들 뿐입니다.
2. **가장 큰 위험부터 판단하라.**
3. **혼자 해결하려 하지 말라.** 우리 칸이 아닌 것은 요청합니다.
4. **조직과 네트워크를 움직여라.**
5. **모르는 것도 솔직하게 소통하고,** 경험을 다음 위기의 역량으로 바꿔라.

결정이 막힐 때 되묻는 세 가지

- **지금 안 하면 안 되는 것은 무엇인가** — 결과를 기다리는 동안에도 할 수 있는 조치(분리 · 감염관리 강화)가 있습니다.
- **되돌릴 수 있는 결정인가** — 되돌리기 어려울수록 근거와 대안을 더 검토합니다.
- **이 조치로 더 어려워지는 사람은 누구인가** — 영향과 보완조치를 기록에 함께 적습니다.

상황판 고정 양식 매일 아침 상황회의 첫 장은 세 칸입니다 — **지금 아는 것 / 아직 모르는 것 / 알아내려고 하는 것(언제 나오는가)**. '모르는 칸'이 비어 있는 상황판은 모른다는 사실조차 모르고 있다는 뜻입니다.

부록 2

부임 후 90일 위기대비 점검표 (1/2)

준비는 문서가 아니라 연락처와 사람입니다. 담당 · 완료일을 채워 결재에 붙이십시오.

쓰는 시점
부임 직후

첫 1주 — 내일 출근하면 확인할 다섯 가지(하나만 해도 됩니다)

번호	점검 항목	확인 방법	담당	완료일	확인
1-1	**감염병 비상연락망이 최신인가**	개인 휴대번호 · 야간 · 휴일 포함 여부 확인. 첫 번째 번호로 야간에 실제 시험호출			☐
1-2	**핵심 담당자 부재 시 대행자가 지정되어 있고, 본인이 알고 있는가**	대행자 본인에게 직접 확인(지정만 하고 본인이 모르는 경우가 많음)			☐
1-3	**위기 시 유지 · 확대 · 축소 · 중단할 업무가 문서로 정해져 있는가**	지역보건의료계획 연차별 시행계획과 함께 제출한 '보건소 업무조정표' 확인(부록 4)			☐
1-4	**오늘 밤 집단발생이 나면 연락할 의료기관 · 시 · 도 담당자를 아는가**	세 사람의 이름과 번호를 보건소장 휴대폰에 저장			☐
1-5	**주민 · 언론 · 단체장에게 누가 무엇을 설명할지 정해져 있는가**	대변인 1인과 대리자 지정(부록 6)			☐

30일 이내 — 사람과 우선순위 정하기

번호	점검 항목	기준 · 방법	담당	완료일	확인
2-1	**상황실 9개 기능 배치표에 성명 · 연락처 · 대체자를 적어 게시**	총괄 · 지휘(보건소장) / 상황관리 / 현장대응 / 역학 · 감시 · 검사 / 환자 · 의료대응 / 자원 · 물류 / 행정 · 재정 / 대외협력 / 위험소통			☐
2-2	**관내 위험요인 목록 작성, 상위 1~3개 선정**	발생 가능성과 예상 피해(취약성 반영)를 평가하고 대응역량 부족 정도로 보정. 세계보건기구(WHO) 위험평가 도구 STAR(2021)의 구조 참고			☐
2-3	**기초 자원 현황 파악**	요양병원 · 요양시설 · 주간보호시설 수, 음압병상 보유 병원, 검사 의뢰 경로, 고령 · 외국인 · 독거 인구			☐
2-4	**주간 감시자료 검토 요일 · 담당 · 보고 기준 지정**	'시간 날 때'가 아니라 '매주 ○요일 오전'. 감염병별로 예년 같은 시기 대비 보고 기준 설정			☐
2-5	**신고 접수 서식 첫 줄에 해외여행력 · 의료기관 방문력**	2015년 메르스에서는 여행력 확인 지연이 진단 지연으로 이어짐			☐
2-6	**'증상 발생 → 첫 보고' 소요시간을 매 건 기록**	월별 평균으로 우리 보건소의 반응 속도 확인. 측정하지 않는 시간은 줄지 않음			☐
2-7	**역학조사 서식(섭취력 조사 등) 사전 준비**	발생 후 만들면 기억이 가장 선명한 초기 며칠 자료를 잃음. 식품 의심 시 식품위생 부서와 합동조사			☐
2-8	**업무조정표 재검토와 보건소장 최종 검토**	사업부서 작성 → 내부회의 → 보건소장 최종 검토(부록 4)			☐
2-9	**업무 복수담당제, 대체인력 명단**	감염병 핵심업무별 2인 이상 숙지. 비상 교대체계 설계			☐

자가점검 다섯 질문 — 답이 바로 나오지 않는 항목이 먼저 챙길 일입니다

1. 지금 휴대폰에서 시 · 도 감염병 담당 과장 번호를 바로 찾을 수 있는가
2. 관내 음압병상을 가진 병원 이름을 댈 수 있는가
3. 오늘 밤 집단발생이 나면 누가 상황실장인가
4. 그 사람이 휴가 중이면 누가 대신하는가
5. 우리 보건소의 업무조정표를 본 적이 있는가

부록 2

부임 후 90일 위기대비 점검표 (2/2)

훈련 일정은 보건소장이 잡아야 실제로 움직입니다. 담당자가 잡으면 다른 일에 밀립니다.

쓰는 시점
부임 90일 이내

90일 이내 — 훈련과 정례 점검 주기 확정

번호	점검 항목	권고 주기 · 방법	담당	완료일	확인
3-1	**야간 · 휴일 핫라인 시험호출 정례화**	분기 1회. 대표번호가 아닌 개인 휴대번호 포함. 담당자 변경 시 당일 갱신			☐
3-2	**관내 의료기관 감염관리 담당자 연락망 갱신**	분기 1회. 전화가 연결되지 않으면 절차는 없는 것과 같음			☐
3-3	**의사회 · 약사회 · 교육청 간담회**	반기 1회. 위기 때 처음 명함을 꺼내는 관계가 되지 않도록			☐
3-4	**연간 훈련계획 수립과 유관기관 참여 조정**	도상훈련 연 2회, 실기훈련 연 1회. 결과를 기록해 차기 점검에 반영			☐
3-5	**감염취약시설 토론형 모의훈련**	부산시 시나리오(2026) 활용. 실제 시설 도면과 종사자 인력을 반영			☐
3-6	**시설과 '현장조사 전 제출자료' 목록 공유**	명단, 급여제공기록, 등하원 목록, 평면도, 환기시설, CCTV. 시설별 보건소 연락 담당자 1명과 대체인력 방안 지정			☐
3-7	**미접종 · 불완전접종 아동 명단 대조**	연 1회, 예방접종통합관리시스템 자료			☐
3-8	**학교 · 어린이집 접종 협조 창구 지정, 의료기관 종사자 면역 여부 파악**	홍역은 의료기관 안에서 전파가 반복됨. 2001년 캐치업 접종은 학교 거점으로 시행			☐
3-9	**N95 밀착도 검사, 재고 · 크기 점검**	재고 · 크기 월 1회. 착용할 때마다 밀착 확인			☐
3-10	**보호구 교육을 '투입 직전 재교육 + 주기적 실습'으로 전환**	체크리스트와 수행 확인 포함. 고위험 감염병은 훈련된 관찰자 감독			☐
3-11	**직원 감염병 예방 · 관리 교육 이수 현황 확인**	법정 교육(2024.9.15 시행): 일반 공무원 연 1시간, 보건소 등 지역보건의료기관 직원 연 4시간, 역학조사반원 연 10시간 이상			☐
3-12	**다국어 표준안내문 비치, 통역 연결 경로 확인**	검사 · 격리 · 예방수칙 3종을 관내 주요 언어로 평시 보유(부록 7)			☐
3-13	**첫 공지문 틀과 예상질의 사전 결재**	4요소 최초 메시지 틀, 자주 묻는 질문 답변안(부록 6)			☐

※ 분기 · 반기 · 연 2회 등 주기는 강의에서 제시한 권고이며 법정 주기가 아닙니다. 기관 여건에 맞게 조정하십시오.

상황실 9개 기능 배치표 — 이 표를 채워 벽에 붙이는 것이 상황실의 전부입니다

기능	담당자(성명)	연락처(휴대)	대체자(성명)	연락처(휴대)
총괄 · 지휘	보건소장			
상황관리				
현장대응				
역학 · 감시 · 검사				
환자 · 의료대응				
자원 · 물류				
행정 · 재정				
대외협력				
위험소통(대변인)				

※ 교육용 9개 기능 예시입니다. 기능과 담당자는 기관 여건에 맞게 조정합니다. 작성일 _____ 갱신 주기 _____

근거 · 강의 40쪽(홍역), 43쪽 · 50쪽(시설 모의훈련 · 초동조치), 57–58쪽(상황실 9기능 · 협력), 67 · 76쪽(보호구 교육 · N95) · 감염병예방법 제18조의5 · 시행령 제17조(감염병 교육) · 부산시 모의훈련 시나리오(2026)

부록 3

첫 24시간 · 72시간 행동 점검표 (1/2)

보고를 받은 자리에서 열 개를 묻고, 다섯 단계로 판단합니다.

쓰는 시점
위기 인지 직후

보고를 받으면 묻는 열 가지 — 먼저 물어야 사실이 남고, 나중에 물으면 기억이 남습니다

순	질문	이 답으로 정해지는 것	받아 적기
1	**무슨 일이 발생했는가**	사실과 추측의 분리('~인 것 같습니다'는 추측)	
2	**언제부터 발생했는가**	증상 시작일에서 잠복기만큼 거슬러 올라가 노출 시점 추정	
3	**몇 명인가**	동원할 자원의 규모	
4	**어디에서 발생했는가**	층 · 병동 단위인지 시설 전체인지	
5	**누가 영향을 받고 있는가**	입소자 · 직원 구분(직원 포함 시 인력 손실과 전파원 문제)	
6	**중증환자 · 사망자가 있는가**	중증도와 지원 요청의 긴급성	
7	**추가 발생이 계속되는가**	진행형인지 종료형인지	
8	**공통 노출 · 연결고리가 있는가**	전파를 끊을 지점(공통 감염원 · 장소)	
9	**지금까지 어떤 조치를 했는가**	중복 지시와 공백 방지	
10	**지금 즉시 필요한 지원은 무엇인가**	시 · 도에 전화해서 말할 내용. 빠뜨리면 지원 요청이 늦어짐	

감염병 초기 판단 5단계 — 발생 확인 · 보고 · 환자 분리 · 위험평가는 병행합니다

단계	확인 · 결정할 것	확인
1. 발생현황 확인	어떤 감염병인가(원인 미상이면 증상군으로 선제 대응) · 몇 명 · 어디서 · 언제부터 / 국가 위기경보 수준과 우리 업무조정 단계(C · B · A, 부록 4) / 시 · 도와 보건소 중 어디가 주관하는가	☐
2. 지침 숙지	질병관리청 해당 감염병 대응지침 **최신판**에서 잠복기 · 전파경로 · 중증 위험, 격리 장소 · 기간, 접촉자 범위, 예방접종 여부 확인	☐
3. 주의사항 검토	대변인 1명 지정 · 언론 대비 / 담당자 부재 시 대리자 / 기관별 역할 / 취약계층 · 감염취약시설 포함 여부	☐
4. 초기회의	참석자 확정 / 상황실 9개 기능에 이름 배치 / 업무조정 단계 결정 / **다음 회의 시각 고정**	☐
5. 업무분장	보건소(역학조사 · 접촉자 관리 · 검사 · 주민 안내) / 의료기관(진단 · 치료) / 시 · 도(조정 · 병상 배정 지원) / 질병관리청(기준 제시 · 기술지원)	☐

※ 검사 범위 · 격리 · 접촉자 관리 · 면회 조정은 위험평가와 해당 감염병 지침에 따라 결정합니다. 감염병 여부가 불분명해도 발병원인을 조사할 필요가 있으면 감염병예방법 제18조에 따라 역학조사를 합니다.

결정할 때 밟는 일곱 칸

① 상황	② 위험	③ 불확실	④ 조치	⑤ 자원	⑥ 협력	⑦ 소통
무슨 일이 일어났는가	가장 큰 위험은 무엇인가	무엇을 모르는가	**지금 안 하면 안 되는 것**	우리 역량으로 가능한가	누구와 움직일 것인가	누구에게 무엇을 말할 것인가

부록 3

첫 24시간 · 72시간 행동 점검표 (2/2)

초기 72시간은 판단 · 행동 · 확인 · 수정의 반복입니다.

쓰는 시점
인지 후 72시간

시간대별 점검 — 구간마다 던지는 질문이 다릅니다

구간	핵심 질문	보건소장이 확인할 것	놓치면	완료 시각
최초 30분	**무슨 일이 일어나고 있는가**	☐ 시 · 도 유선보고 ☐ 유증상자 분리 지시 ☐ 첫 10개 질문 기록	노출자가 계속 늘어난다	
최초 2시간	**지금 무엇을 결정해야 하는가**	☐ 상황실 가동, 9개 기능 배치표 게시 ☐ 첫 상황보고서 ☐ 의사결정 기록지 작성(부록 5) ☐ 대변인 지정, 첫 공지 준비(부록 6)	지시가 중복되거나 공백이 생긴다	
최초 24시간	**우리 역량으로 충분한가**	☐ 부족분을 수치로 적은 지원요청 공문 ☐ 인력 재배치안, 교대 편성 ☐ 업무조정 단계 검토(부록 4) ☐ 일일 상황회의 시각 고정	직원이 먼저 쓰러진다	
최초 72시간	**현재 전략이 효과가 있는가**	☐ 전략 수정 여부 결정 ☐ 업무조정 단계 재검토 ☐ 조치별 해제(중단) 조건 점검 ☐ 휴식 · 교대 이행 확인(부록 8)	틀린 결정을 관성으로 끝까지 안고 간다	

※ 이 시간 구분은 법적 대응시간 기준이 아니라 보건소장의 초기 대응 사고훈련을 위한 교육적 구분입니다.

시설의 첫 2시간 — 평시에 정해 두게 합니다

시간	시설이 할 일
0~10분	시설장 · 감염관리책임자 즉시 보고, 임시 대기공간 마련, 보호구를 착용한 직원이 분리
10~30분	관할 보건소 · 구에 즉시 신고, 보호자 연락과 인계 시각 확인, 마스크 재점검, 추가 유증상자 확인
30~60분	접촉자와 노출 공간 파악(식당 · 수면실 · 송영차량), 발생 구역 소독 · 환기, 보호자 긴급 안내
1~2시간	보건소 역학조사 대응과 명부 제공, 접촉자 관리 방안 · 방역물품 · 운영방안 검토

※ 부산시 주간보호시설 시나리오(2026) 기준 교육용 예시입니다. 접촉자 분류는 보건소가 합니다.

현장조사 전에 받을 자료

- ☐ 입소자 · 이용자 · 종사자 명단
- ☐ 급여제공기록, 등하원 목록
- ☐ 종사자 근무표, 교차근무 현황
- ☐ 평면도, 환기시설 현황
- ☐ 면회기록, CCTV

지원을 요청할 때의 다섯 문장

1. **상황** — 이런 상황입니다.
2. **부족** — 이것이 부족합니다(수치로: 조사 가능 ○명, 필요 ○명).
3. **위험** — 그래서 이 위험이 예상됩니다.
4. **대안** — 대신 이것을 하겠습니다.
5. **요청** — 이 지원이 필요합니다.

늦은 발견을 줄이는 네 가지 절차 — 지연은 사고가 아니라 절차의 결과입니다

① 먼저 묻기
신고 접수 시 여행력과 의료기관 방문력을 먼저 묻습니다.

② 시간 재기
증상 발생부터 첫 보고까지 걸린 시간을 매 건 기록합니다.

③ 연락망 갱신
의료기관 감염관리 담당자 연락망을 분기마다 갱신합니다.

④ 경로 시험
야간 · 휴일 신고 접수 경로를 실제로 한 번 시험합니다.

2015년 메르스 첫 환자는 증상 시작(5.11) 후 9일이 지난 5.20에 확진되었고, 그 사이 4개 의료기관을 거쳤습니다. 최종 확진 186명, 사망 38명. 초기 발견과 대응의 지연은 유행 확대의 중요한 위험요인이 됩니다.

부록 4

위기단계별 보건소 업무조정 기준표 (1/2)

감염병을 막으면서도 멈추면 안 되는 일이 있습니다. 무엇을 유지할지는 평시에 정합니다.

쓰는 시점
평시 작성 · 경보 상향

국가 위기경보와 보건소 업무조정 위기단계는 서로 다른 것입니다. 국가 위기경보(관심 · 주의 · 경계 · 심각)는 나라 전체의 위기 수준을 중앙이 발령합니다. 업무조정 위기단계(C · B · A)는 **우리 보건소의 평소 사업을 어디까지 유지할지** 정하는 단계로, 보건소장이 지역 여건을 고려해 자체적으로 정할 수 있습니다. **C가 가장 낮고 A가 가장 높은 단계**입니다.

국가 위기경보 수준 — 4단계

수준	정의
관심	위기징후 현상이 나타나나 활동수준이 낮아 국가위기로 발전될 가능성이 낮은 상태
주의	위기징후 활동이 비교적 활발하고 국가위기로 발전될 수 있는 일정 수준의 경향성이 나타나는 상태
경계	위기징후 활동이 활발하고 국가위기로 발전될 가능성이 높은 상태
심각	위기징후 활동이 매우 활발하고 전개속도 · 경향성이 심각한 수준으로 국가위기 발생이 확실한 상태

보건소 업무조정 위기단계 — 3단계

단계	판단기준	수행 업무
C	개인방역 수칙을 준수하며 집합금지 · 사적모임에 제한을 두지 않는 단계 지속적 억제 · 과거 거리두기 1단계 수준	**C + B + A** 보건소 전체 업무
B	사적모임 금지, 이용인원 제한 등 개인활동에 제한을 두는 단계 지역 · 권역 유행 · 과거 2~3단계 수준	**B + A** 여건에 따라 C 업무도 가능
A	외출 및 집합 · 행사 금지 수준 단계 대유행 · 과거 4단계 수준	**A** 최소한의 필수업무

※ 판단기준은 감염병 유행과 지역 방역 상황에 따라 바뀔 수 있는 참고자료이며 절대적 기준이 아닙니다. A단계 업무의 증가는 가능하나, 감소는 지자체 여건상 불가피한 경우에만 변경하도록 권고됩니다. 시 · 도와 시 · 군 · 구 보건소는 국가 위기경보 **'주의' 발령부터** 지역방역대책반을 운영하고 방역업무 중심의 기능개편 · 인력보강을 준비합니다.

위기단계는 누가, 어떻게 정하는가

보건소장의 결정 권한

- 보건소장은 판단기준과 지자체 여건 · 상황을 고려하여 **자체적으로 위기단계를 결정**할 수 있습니다.
- 필요하면 **'업무조정 위기단계 평가회의'**를 소집합니다. 보건소장이 총괄하며, 위기관리기구 · 지역보건의료기관협의회 · 유관기관과 전문가로 구성할 수 있습니다.
- 단계는 반드시 순차적(C→B→A)으로 적용할 필요가 없으며 지역 상황에 따라 유연하게 적용합니다.

결정할 때 고려할 것

☐ 국가 위기경보 수준 ☐ 사회적 거리두기 단계
☐ 감염병 종류 ☐ 지자체 확진자 수 ☐ 확산 정도
☐ 중증도 ☐ 지역 대응역량 ☐ 지역 보건의료 자원

위기단계 결정은 '보건소 업무조정'을 위한 절차로만 활용합니다. 감염병 재난의 위기관리와 방역체계 운영은 관련 법령 · 지침을 따르며, 위기관리 기구 · 중앙행정기관이 전국 보건소 업무를 총괄 · 조정하는 경우에는 그에 따릅니다.

업무 우선순위 판단기준 — 위기 시에도 우선 추진할 업무를 고르는 기준

구분	판단기준
반드시 고려	① 보건소 필수 법적 업무(식품 · 공중위생, 의약무, 응급의료, 감염병 등)
	② 타 기관에서 수행하지 않아(한시적으로도) 대체 불가능한 업무
	③ 긴급 · 응급성이 높고, 생명과 관련하여 시기가 정해져 있어 즉시 수행하지 않으면 더 큰 피해 · 손실이 예상되는 업무
	④ 생계와 관련되어 있거나 취약계층 대상 현금 · 현물 지원이 필요한 업무
	⑤ 취약계층(어르신, 장애인, 기초생활수급자 등) 대상 업무
	⑥ 위탁 수행이 가능한 서비스(유관기관, 민간 등)
선택적 고려	⑦ 비대면으로 전환하여 운영이 가능한 서비스
	⑧ 그 외 지자체 여건과 상황에 따라 필수 · 우선 업무로 판단되는 사업

부록 4

위기단계별 보건소 업무조정 기준표 (2/2)

업무조정표는 연초 지역보건의료계획 시행계획과 함께 작성 · 제출하고 상시 준비합니다.

쓰는 시점
평시 작성 · 위기 적용

위기단계별 업무 유형 — 업무조정표를 작성할 때 참고하는 공통 분류

단계	성격	업무 유형 예시
C	보건소 전체 업무	계획수립 · 보고(충무계획), 교육 · 상담 · 평가, 대상자 등록 · 관리(신규), 모니터링, 사후관리(건강검진 등), 시설 확충 및 장비 · 물품관리, 예방접종, 자료 작성 · 검토, 제증명 발급, 조례 제 · 개정, 조사 · 분석(역학조사 이외), 홍보 · 안내 · 캠페인
B	비교적 긴급성이 높은 업무(긴급성 낮은 업무 중단, 비대면 중심 · 대면 축소)	계약 · 협약 체결(신규), 계획수립 · 보고(중장기 · 연차별), 교육 · 상담 · 평가(비대면, 대면은 취약계층에 한함), 대상자 등록 · 관리(기존), 연계협력 · 체계, 조직 · 단체 운영, 지도 · 점검, 행정처분 · 소송, 홍보 · 안내 · 캠페인(비대면, 대면은 취약계층에 한함)
A	긴급성 높은 업무, 생계 관련 업무, 취약계층 대상 업무, 기존 위탁방식 업무	검체채취 · 의뢰, 기관 · 담당자 관리, 대상자 등록 · 관리(기존 취약계층), 민원접수 · 처리, 서비스 운영 · 지원, 신고 접수 · 수리 · 보고, **신속 · 즉시 보고(감염병 등)**, 예산 조정 · 배분 · 교부, 위탁기관 운영관리, **조사 · 분석(감염병 역학조사 등 긴급한 경우)**, 진료 · 치료 · 검진, 현금 · 현물 지원

※ 사업 특성과 지자체 상황에 따라 단계별 업무 유형은 달라질 수 있습니다. 같은 유형이라도 취약계층(어르신 · 장애인 · 기초생활수급자) 대상 업무는 단계 상향 조정이 권고됩니다. 감염병 위기 시 해당 '유행 감염병' 대응업무는 사례표에 포함되어 있지 않습니다.

평시 절차 — 4단계

1. **사례표 검토**(사업부서) — 안내서 사례표와 우리 보건소 전체 사업 · 업무목록 검토
2. **업무조정표 작성**(사업부서) — 자체사업 · 시범사업 · 공약사업까지 현행화하고 단계별로 조정
3. **조정 논의 · 검토**(사업부서, 보건소장) — 내부회의로 단계별 우선순위 조정, **보건소장 최종 검토**
4. **업무조정표 마련**(사업부서) — 최종 작성본을 연차별 시행계획 수립 시 함께 제출

위기 시 절차 — 4단계

1. **업무조정표 재검토**(사업부서) — 변동사항 현행화, 보건소장 최종 검토
2. **위기단계 결정**(보건소장) — 필요 시 평가회의 소집
3. **적용 시점 결정 · 시행**(사업부서) — 전 직원 공유, 실무 담당자에게 조정 내용 전달
4. **환류**(위기 회복 후, 사업부서) — 시행 개선사항 환류와 재조정

우리 보건소 결정 기록 — 단계를 정하면 전 직원에게 공지합니다

결정 단계	☐ C ☐ B ☐ A	**적용 시점**		**재검토 예정일**	
결정 근거					

※ 강의에서는 사업을 **유지 / 확대 / 축소 · 전환 / 일시 중단 가능**의 네 칸으로 나누어 설명했습니다(교육용 분류). 법정 기한 · 계약 의무가 있는 일은 자동 중단되지 않습니다.

위기 이후 업무회복 점검 — 보건소장 · 부서장

구분	점검 · 준비 사항	확인
조직	감염병 대응조직(신규부서) 파악과 역할 명확화, 보건소 내부 조직 · 체계 재점검	☐
인력	유지 사업과 중단 후 재개 사업 전반의 인력배치 파악, 필요 전문인력(자격 · 면허)의 적재적소 배치 확인	☐
업무	위기 이후 업무량이 늘었거나 신규 추가된 업무, 지속 모니터링이 필요한 업무 파악 → 인력 확보 · 추가 배치 검토	☐
협력기관	내 · 외부 연계협력기관과 담당자 현행화, 조직 · 인력 이동 시 인수인계	☐
상시 대비	다음 신종감염병에 필수적인 조직 · 전문인력 · 예산 · 시설 · 장비 파악	☐
재개 공지	언제부터 무엇을 재개할지 **날짜를 정해** 공지('차차 정상화'로는 움직이지 않음)	☐

보건소장 결정사항 소진 대책 네 가지 가운데 '일을 줄인다(업무조정표 적용 · 보고 양식 통합 · 회의 축소)'는 다른 기관의 동의 없이 보건소장 결재로 바로 시행할 수 있습니다.

부록 5

불확실성 속 의사결정 기록지 (양식)

결정은 한 장에 남깁니다. 기록은 책임을 피하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것입니다.

쓰는 시점
주요 결정마다

사건명			
보고받은 시각		**보고자 · 경로**	
결정 시각		**재평가 시각**	

① 상황 — 세 칸으로 나눕니다

지금 아는 것(확인된 사실)	아직 모르는 것	알아내려고 하는 것(누가 · 언제까지)

※ '확진'과 '유증상'을 구분해 적습니다. 원인이 확인되기 전에는 '증상이 있는 사람 ○명'입니다.

② 결정 — 지금 안 하면 안 되는 것

우선 조치	
판단 근거	발생 현황 · 위험평가 · 적용 지침(명칭 · 판) · 법적 권한(조문)
검토한 대안	덜 제한적인 방법은 없었는가
해제(중단) 조건	무엇이 바뀌면 이 조치를 되돌리는가 — 결정하는 시점에 함께 정합니다
취약계층 영향과 보완조치	이 조치로 더 어려워지는 사람은 누구인가

③ 실행 — 부서명이 아니라 사람 이름을 적습니다

기능	담당자(성명)	기능	담당자(성명)
역학조사		**의료기관 협력**	
상황관리		**위험소통(대변인)**	

④ 보고 · 협의 — 구두 협의도 통화 후 한 줄 메모하면 근거가 됩니다

상대(기관 · 성명)	시각	협의 내용 · 결과
시 · 도 감염병 담당 부서		
구청장 등 지자체 지휘체계		

작성		**확인(보건소장)**	

※ 교육용 양식입니다. 실제 대응에서는 적용 감염병 지침 · 법적 조치권한 · 보고체계에 따라 항목을 조정합니다.

부록 5

불확실성 속 의사결정 기록지 (작성 안내)

불확실하다는 것은 결정하지 않을 이유가 아니라, 불확실성을 고려해서 결정할 이유입니다.

쓰는 시점 **결정 전 5분**

결정을 미루고 싶을 때 따지는 여섯 기준

기준	스스로 묻는 질문	메모
시급성	지금 하지 않으면 피해가 커지는가	
예상 피해	틀렸을 때 최악의 결과는 무엇인가	
되돌릴 수 있는가	되돌릴 수 있는 결정인가(면회 제한은 비교적 되돌리기 쉽고, 시설 운영 중단은 어렵습니다)	
기다리는 비용	기다리는 동안 노출이 얼마나 늘어나는가	
법적 근거와 권한	누가, 어떤 근거로 할 수 있는 조치인가	
비례성과 대안	덜 제한적인 방법은 없는가	

※ 정해진 시간 기준이 있는 것은 아닙니다. 판단하되 그 근거를 반드시 기록합니다. 되돌리기 어려운 결정일수록 근거와 대안을 더 신중하게 검토합니다.

사회대응 수단을 적용할 때의 여섯 고려요소 — 「감염병 위기 사회대응 매뉴얼」(질병관리청, 2026)

효과성
감염 확산을 억제하고 위험을 줄일 수 있는가

실현가능성
자원 · 행정 · 법적으로 실행할 수 있는가

사회적 수용성
주민이 받아들일 수 있는가

형평성
취약계층과 사회적 약자에게 어떤 영향을 주는가

의도하지 않은 부정적 영향
개인건강, 의료대응, 사회경제에 미치는 영향

보호 조치 필요성
사회보호 정책이나 지역사회 지원이 함께 필요한가

과잉금지 원칙 조치는 위험 수준에 비례하여, 기본권과 사회 · 경제적 영향을 고려해 필요한 최소 범위에서 시행합니다. 사회대응 수단은 중앙위기관리기구가 적용 수준과 범위를 결정하고, 지방정부는 그 범위 안에서 지역 특성을 반영해 시행하며, 지역 유행 상황 · 주민 수용성 · 취약계층 영향을 모니터링해 중앙에 환류합니다.

중앙 지침을 그대로 실행하기 어려울 때 — 임의로 무시해서도, 기계적으로 하는 척해서도 안 됩니다

실행할 수 있다면

1. 지침의 성격 확인 — **법적 의무인가 권고인가**
2. 실행 시점과 담당 부서 지정
3. 실행 결과를 기록으로 남김

실행하기 어렵다면

1. **부족한 것을 수치로** — '인력이 없습니다'가 아니라 '조사 가능 3명, 필요 8명'
2. 그대로 할 때의 위험과 바꿀 때의 위험 비교
3. 실행 가능한 대안 1~2안 작성
4. 판단근거 · 협의내용 · 결정시점 기록

양쪽으로 틀려도 설명할 수 있으려면

순	남길 것	이유
1	결정 시각 · 판단 근거 · 참고한 지침을 **그 자리에서** 한 장에 기록	나중에 재구성하면 이미 늦습니다. 기억은 왜곡됩니다.
2	상급기관 협의 내용과 상대방 이름	구두 협의도 기록하면 근거가 됩니다.
3	**조치를 되돌릴 조건(중단 기준)**을 결정 시점에 함께 정함	되돌리는 일이 실패가 아니라 절차가 됩니다. 기간은 감염병 지침에 따릅니다.
4	주민에게 '아직 모르는 것'을 먼저 말함	불확실성을 숨기면 나중에 신뢰로 갚아야 합니다.

누구의 권한인가 역학조사(제18조), 강제처분(제42조), 유행 시 방역 조치(제47조), 예방 조치(제49조)는 법에서 주체를 **'질병관리청장, 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장'**으로 정합니다. 보건소장은 우리 지자체의 사무 위임 · 전결 규정에 따라 수행하므로, 처분 전에 **명의와 전결 범위**를 확인합니다.

부록 6

위기소통 문안 틀 (1/2) 첫 공지

공백은 반드시 채워집니다. 우리가 채우지 않으면 거짓정보가 채웁니다.

쓰는 시점
첫 공지 전

확인된 사실은 신속하게, 확인 중인 내용은 불확실성을 명시하여 알립니다. 확인될 때까지 침묵하는 것이 아닙니다. 가장 어려운 말은 '모릅니다'가 아니라, 나중에 '아니라고 했던 것'입니다.

다섯 가지 원칙과 그대로 읽는 문장 — 영문 첫 글자를 딴 EATEA(교육용 기억법) · 사례: 요양병원 호흡기 집단발생

원칙	뜻	예시 문장
먼저(Early)	먼저 말한다	"오늘 오전 관내 요양병원에서 호흡기 증상자 집단발생이 확인되어 알려드립니다."
정확하게(Accurate)	확인된 사실만	"현재 발열 · 호흡기 증상이 있는 입원환자는 12명이며, 모두 같은 층에 있습니다." (원인 확인 전에는 '확진자'가 아니라 '증상이 있는 분')
투명하게(Transparent)	모르는 것은 모른다고	"원인 병원체는 아직 확인되지 않았습니다. 검사 결과는 오늘 오후 늦게 나올 예정입니다."
공감하며(Empathetic)	걱정을 인정한다	"보호자분들이 얼마나 불안하실지 알고 있습니다."
행동을 주며(Actionable)	지금 할 일을 준다	"면회를 예정하셨던 분은 ○○번으로 전화 주십시오. 직접 방문은 삼가 주십시오."

※ 근거는 미국 질병통제예방센터(CDC)의 위기 · 긴급 위험소통(CERC) 6원칙(2018 개정판)입니다 — 먼저 알린다(Be First), 정확하게(Be Right), 신뢰를 지킨다(Be Credible), 공감한다(Express Empathy), 행동을 촉구한다(Promote Action), 존중한다(Show Respect).

최초 메시지 작성 틀 — 네 요소를 채우면 첫 공지가 됩니다

요소	틀	우리 문안
① 현재 확인된 사실	"○월 ○일 ○○동 소재 ○○시설에서 ○명이 ○○ 증상을 보여 확인 중입니다."	
② 아직 확인 중인 사항	"원인과 접촉자 범위는 역학조사 중입니다."	
③ 지금 해야 할 행동	"○○시설 방문 이력이 있는 분은 보건소(☎ ○○○-○○○○)로 연락 주십시오."	
④ 다음 안내 시점	"○월 ○일 ○○시에 추가로 안내드리겠습니다."	

※ 사회대응 조치를 알릴 때에는 조치의 **필요성 · 기대효과 · 적용 범위 · 종료 기준**을 이해하기 쉽게 함께 전달합니다(사회대응 매뉴얼 7-3).

발신 전 점검표

점검 항목	점검 내용	확인
네 요소	확인된 사실 / 확인 중 / 행동 요령 / 다음 안내 시점이 모두 들어 있는가	☐
사실 구분	확인된 사실, 확인 중인 사실, 모르는 것을 섞지 않았는가(섞으면 전부 추측으로 받아들임)	☐
단일 승인선	보건소장 또는 지정 대변인 1인의 결재를 거쳤는가. 부서별 자체 발송은 하지 않는가	☐
메시지 정렬	시 · 도와 질병관리청 발표 내용 · 수치와 엇갈리지 않는가	☐
개인정보	성명 · 상세 주소 등 개인 식별이 가능한 정보가 빠졌는가	☐
낙인 표현	국적 · 직업 · 종교 · 지역 · 시설을 원인으로 지목하는 표현이 없는가	☐
채널 정합성	홈페이지 · SNS · 문자 · 보도자료가 같은 시점, 같은 문안인가	☐
접근성	다국어 안내, 큰 글씨 · 유선 안내 등 정보 취약계층 경로를 함께 준비했는가(부록 7)	☐

근거 · 강의 81쪽(EATEA), 86쪽 · CDC, CERC Manual · 질병관리청 「공중보건 위기소통 표준운영절차」 · 「감염병 위기 사회대응 매뉴얼」(2026) 7-3 · 「보건소 바이블」 제7장(내부 편찬본, 최초 메시지 4요소 · 점검표)

부록 6

위기소통 문안 틀 (2/2) 대상별 소통 · 거짓정보 · 낙인

같은 사실이라도 상대에 따라 먼저 말할 것이 다릅니다.

쓰는 시점
브리핑 · 보고 전

대상별로 먼저 말할 것

상대	먼저 말할 것	하지 말 것	시점
주민	**지금 해야 할 행동**	전문용어, 확정되지 않은 숫자	인지 즉시
언론	확인된 사실 → 모르는 것 → **다음 발표 시각**	추측, 비공식 발언	보도 전에 먼저
직원	파악된 상황과 **오늘의 역할**	"조금만 더 버티자"의 반복	매일 아침 같은 시각
단체장	위험 수준, 필요 지원, 예상 질문	낙관적 전망	언론 보도 전
상급기관	상황 + 제약 + 대안 + **요청사항**	"못 합니다"로 끝내기	확진 전이라도 즉시
의료기관	사례정의(누구를 환자로 보는가), 신고경로, 병상 연계 방법	일방적 협조 요구	인지 즉시

공통 원칙 모를 때는 "모릅니다"로 끝내지 않고 반드시 **"언제 알 수 있는지"**를 붙입니다. "아직 모릅니다"와 "아직 모릅니다, 내일 오전에 나옵니다"는 완전히 다른 말입니다.

브리핑 · 언론 응대 운영

- ☐ **발표 창구를 한 사람으로 고정** — 같은 시각, 같은 창구, 같은 형식
- ☐ 기자 취재는 대변인 창구로 일원화(개별 선조치 후보고 금지)
- ☐ **예상질의와 공식 답변**을 미리 준비
- ☐ 중앙 · 시 · 도와 브리핑문을 상호 공유해 통계와 메시지 기조를 맞춤(한목소리 원칙)
- ☐ 불확실성이 있으면 있다고 알리는 투명한 기조 유지
- ☐ 내부 직원에게 상황과 기관 입장을 먼저 공유
- ☐ 개인 식별이 가능한 정보는 공개하지 않음

거짓정보 대응 네 단계

1. **듣는다** — 무슨 말이 도는가(SNS, 지역 커뮤니티, 민원, 지역 언론)
2. **평가한다** — 확산 정도, 건강행동 영향, 취약계층 피해 가능성
3. **대응한다** — 순서 고정: 사실 → 불확실한 것 → 해야 할 행동 → 확인 방법
4. **전달자를 고른다** — 신뢰받는 사람이 말하게 함(의료인, 의사회, 학교, 복지기관, 통장, 이주민 커뮤니티)

※ 목적은 논쟁에서 이기는 것이 아니라 신뢰를 지키는 것입니다. 영향이 작으면 모니터링을 유지하며 대응 수준을 조절하고, 커지면 바로 대응 단계로 올립니다. 가장 효과적인 예방은 투명한 공개입니다.

낙인을 만들지 않는 표현 — 낙인이 생기면 사람들이 숨고, 숨으면 찾지 못합니다

피할 표현	대신 쓸 표현
질병 이름에 지역 · 민족 · 국적을 붙이는 표현	공식 질병명
환자를 '희생자' · '피해자'로 부르는 표현	'○○에 걸린 분', '치료를 받고 있는 분', '회복 중인 분'
'용의자' · '의심자'	'감염되었을 가능성이 있는 분'
접촉자를 '퍼뜨리는 사람들'로 부르는 표현	'감염된', '걸린' 등 책임을 지우지 않는 표현
확인되지 않은 소문의 반복 · 과장	확인된 사실과 예방 행동
특정 직업군 · 국적 · 시설을 원인으로 지목	'○월 ○일 ○○시설 집단발생' 등 사실 중심 표현

정보공개의 법적 근거 — 감염병예방법

제6조 제2항

국민은 감염병 발생 상황, 예방 · 관리 등에 관한 정보와 대응방법을 알 권리가 있고, 국가와 지방자치단체는 신속하게 정보를 공개하여야 합니다.

제34조의2(감염병위기 시 정보공개)

'주의' 이상 위기경보가 발령되면 환자의 이동경로 · 이동수단 · 진료의료기관 · 접촉자 현황 등 예방에 필요한 정보를 신속히 공개합니다. **성명, 읍 · 면 · 동 이하 주소** 등은 제외하고(시행령 제22조의2), 공개 목적을 달성하면 지체 없이 삭제합니다.

2015년 메르스의 교훈 혼란과 낙인을 우려한 의료기관명 비공개 → 정보 공백 → 근거 없는 병원 명단 유통 → 신뢰 저하 → 뒤늦은 공개. 비공개는 보호가 아니라 지연이었습니다.

근거 · 강의 74쪽(낙인), 82–83쪽 · 85–86쪽 · 질병관리청 「공중보건 위기소통 표준운영절차」(창구 일원화 · 한목소리 원칙) · 감염병예방법 시행령 제22조의2 · IFRC · UNICEF · WHO, Social Stigma associated with COVID-19(2020.2.24)

부록 7

취약계층 · 외국인 주민 보호 점검표

조치를 결정하기 전에 묻습니다 — “이 조치로 더 어려워지는 사람은 누구인가.”

쓰는 시점
조치 결정 전후

형평성과 수용성은 사회대응의 기본 원칙입니다. 조치를 시행할 때 감염취약계층 보호를 강화하고, 충분한 소통과 보호 조치를 병행합니다. 취약계층에 미치는 영향과 보완조치는 의사결정 기록지(부록 5)에 함께 적습니다.

집단별 영향과 보완조치

집단	조치로 생기는 어려움	보완조치	담당	확인
독거노인 · 고령층	안내문을 보지 못하거나 읽기 어려움	통장 · 반장 전달, 유선 안내, 큰 글씨 안내문		☐
장애인	선별진료 · 검사 접근 곤란	방문검진, 수어 · 자막 안내		☐
이주민 · 외국인근로자	언어 장벽, 체류자격 불안으로 인한 검사 기피	다국어 안내, 사업주 · 지원센터 · 종교기관 경유, **‘체류자격과 무관하게 검사 · 치료를 받을 수 있다’는 점 명시**		☐
저소득층 · 노숙인	격리할 공간이 없음	임시 주거와 생활지원 연계		☐
디지털 소외계층	QR · 앱 기반 안내 이용 불가	유선과 종이 안내 병행		☐
감염취약시설 입소자	면회 제한으로 인한 고립	비대면 면회 체계, 보호자 정기 안내		☐

외국인 주민 소통 점검 — 평시에 준비하고 위기 때 바로 가동합니다

구분	점검 내용	확인
현황 파악	관내 외국인 주민의 국적 · 언어 분포, 외국인근로자 다수 고용 사업장 명부와 사업주 연락처	☐
다국어 안내문	검사 안내 · 격리 안내 · 예방수칙 3종을 관내 주요 언어로 평시 비치(예: 영어, 중국어, 베트남어, 태국어, 우즈베크어, 러시아어 등 분포에 따라 선정)	☐
핵심 문장	모든 안내문에 **“체류자격과 관계없이 검사와 치료를 받을 수 있습니다”**를 포함. 이 한 문장이 없으면 오지 않습니다.	☐
전달 경로	사업주, 외국인지원센터 · 가족센터, 종교기관, 이주민 공동체 대표, 다국어 SNS 채널	☐
통역 연결	통역 지원 창구와 야간 연락 경로를 사전 등록(예: 다누리콜센터 ☎ 1577-1366 · 13개 언어, BBB 코리아 ☎ 1588-5644 · 24시간 전화 통역 — 운영 내용은 배포 전 확인)	☐
신뢰받는 전달자	공동체 안에서 신뢰받는 사람이 같은 내용을 전달하도록 요청(거짓정보 대응 4단계와 연결)	☐
표현 점검	특정 국적 · 직업 · 종교 · 사업장을 원인으로 지목하는 표현 금지(부록 6)	☐
격리 · 생활지원	기숙사 등 공동거주자의 격리 공간, 식사 · 생필품, 임금 · 고용 관련 상담 연계	☐

근거

- **감염병예방법 제49조의2**(감염취약계층의 보호 조치) — ‘주의’ 이상 위기경보 시 감염취약계층에 대한 의료 · 방역물품 지급 등 보호 조치의 근거
- **「감염병 위기 사회대응 매뉴얼」(2026)** — 4대 기본원칙 중 형평성 · 수용성, 적용 6요소 중 형평성 · 보호 조치 필요성
- **업무조정 안내서** — 취약계층 대상 업무는 우선순위 판단의 필수 고려 항목이며 단계 상향 조정 권고(부록 4)

‘체류자격과 무관하다’의 법적 근거

공무원은 직무상 미등록 체류자를 알게 되면 통보할 의무가 있으나(출입국관리법 제84조), **공공보건의료기관에서 담당 공무원이 보건의료 활동과 관련하여 환자의 신상정보를 알게 된 경우**에는 통보의무가 면제됩니다(같은 법 시행령 제92조의2 제2호). 보건소의 검사 · 진료 · 역학조사가 여기에 해당하므로 이 점을 안내문에 분명히 적습니다.

회의에서 매번 묻는 한 문장 “이 조치로 더 어려워지는 사람은 누구인가.” 부서장 회의마다 이 질문을 하면, 감사나 의회에서 같은 질문을 받을 때 이미 답이 준비되어 있습니다.

부록 8

종사자 보호 · 소진 관리 점검표

보건소장이 서명하는 근무편성표가 곧 종사자 보호 정책입니다.

쓰는 시점
2주차부터 매주

> **소진은 개인의 체력 문제가 아니라 조직 설계의 문제입니다.** 대책은 격려가 아니라 조치여야 합니다. '조금만 더 버티자'는 대책이 아닙니다.

주간 점검 — 위기 중 매주 같은 요일에 확인합니다

점검일 _____

이번 주 질문	예	아니오	'문제 있음'이면 취할 조치
업무가 특정 직원에게 몰리고 있는가	☐	☐	
장시간 근무가 2주 이상 이어지고 있는가	☐	☐	
휴식과 교대가 근무표대로 지켜지고 있는가	☐	☐	
보고와 회의가 늘었는가	☐	☐	
직원이 "힘들다"고 말할 자리가 있는가	☐	☐	
근무 중 피로 · 신체 이상을 보고하는 절차가 작동하는가	☐	☐	

대책은 네 가지 조치입니다 — 둘은 오늘 결재로 바로 가능합니다

일을 줄인다
업무조정표 적용, 보고 양식 통합, 회의 축소
보건소장 결정

시간을 준다
교대 편성, 강제 휴식, 대체휴무 사전 확정
보건소장 결정

사람을 늘린다
타 부서 지원, 시 · 도 인력 요청, 대체인력 채용
구청장 · 시 · 도 협의

마음을 지킨다
동료 상담, 정신건강복지센터 연계, 상담비 지원
연계 · 예산 조치

※ '쉬라'고 하면 쉬지 않습니다. 근무표에서 빼야 쉽니다.

근무 · 휴식을 근무표에 명시

항목	전문가 권고 사례	우리 기준
전신보호복(레벨 D 이상) 연속 착용	1~4시간	
보호구 착용 근무(1일)	6~8시간	
계획된 휴식	1~2시간마다	

※ 박세윤 외(2023) 지침의 권고이며 **법적 의무 기준이 아닙니다**. 보호구 종류, 작업 강도, 온열환경, 근무자 건강상태, 적용 지침을 고려해 기관이 정합니다.

보호구로 생기는 신체 손상 예방

피부 손상	착용 전후 피부 보호, 압박 부위 관리, 계획된 휴식. 보호재 사용 시 밀착 성능 저하 여부 확인
두통	정해진 휴식 시간에 안전한 장소에서 벗고 쉬기, 수분 · 환기. 지속되면 보고하고 배치 조정
과도한 발한	온열환경과 작업 강도 평가, 착용시간은 현장 위험평가로 결정

보호구 교육 · 훈련 — 보건소장 결재사항

- ☐ 교육을 '투입 직전 재교육 + 주기적 실습'으로 운영
- ☐ 체크리스트로 단계별 수행 확인, 탈의실 절차표 비치
- ☐ 고위험 감염병은 **훈련된 관찰자**가 착탈의 감독(동료 '버디'와 구분)
- ☐ N95 밀착도 검사, 착용 시마다 밀착 확인, 재고 · 크기 월 1회 점검
- ☐ 오류 · 오염 발생 시 절차 중단과 보고 경로 숙지

교대 종료 시 5분 루틴 — 6단계, 팀장급이 매일 진행

1. 잠시 시간을 내어 오늘 하루를 생각한다
2. 어려웠던 한 가지를 인정하고 놓아준다
3. 오늘 잘된 세 가지를 생각한다
4. 동료의 마음이 괜찮은지 확인한다
5. 묻는다 — "괜찮으세요?"
6. 집에서의 생활에 집중한다

평시와 위기 후에 할 일

평시(Before)
업무 복수담당제, 대체인력 명단, 비상 교대체계 설계, 업무조정표 확정과 역할 지정, 정기 교육 · 모의훈련

위기 후(After)
회복기간 지정과 휴가 보장, 직원 경험 공유회, 심리지원 연계, 업무 재조정, 조직 차원의 공식 인정

근거 · 강의 67–80쪽 · 박세윤 외, 의료관련감염관리 2023;28(1):50-63 · CDC, PPE Guidance for VHF(훈련된 관찰자) · Mutch 외(2023) · 5분 루틴은 강의 74쪽 정서적 돌봄 단계를 정리한 것입니다.

부록 9

사후검토(AAR) 진행 양식 (1/2) 진행 안내

사후검토(AAR, After Action Review)는 대응이 끝난 뒤 취한 조치를 되짚어 잘된 점과 고칠 점을 찾는 검토입니다.

쓰는 시점
종료 후 조기

사후검토는 위기의 마지막 단계가 아니라 다음 준비의 첫 단계입니다. 보고서로 끝나는 사후평가는 안 한 것과 같습니다. 결론은 반드시 사람 이름과 날짜로 끝나야 합니다. 담당자와 기한이 비어 있는 개선과제는 그대로 문서보관실로 갑니다.

위기 이후의 세 단계

회복(Recover)
정상업무 복귀, 직원 회복, 미처리 업무, 행정 · 재정 정리
언제부터 무엇을 재개할지 날짜를 정해 공지

평가(Review)
평가회의 개최, 조사보고서 완결
종료 후 가능한 조기에 실시

개선(Improve)
매뉴얼 개정, 교육 · 훈련, 조직 · 인력 개선
개선과제를 다음 해 예산안에 반영

언제, 어떤 방식으로 하는가

구분	기준
국제 권고	세계보건기구(WHO)는 사건 종료 후 **3개월 이내** 실시를 제시
기관 자체 목표	종료 후 **4주 이내** 평가회의 개최 법정 기한이 아니라 기관이 정하는 운영목표입니다. 늦어질수록 기억도 의지도 함께 사라집니다.
예산 연계	다음 해 예산 편성 일정에 맞춰 제출

WHO가 제시한 방식	성격
디브리핑형	대응 참여자가 모여 짧게 진행하는 토의
워킹그룹형	기능 · 분야별 조를 나눠 진행하는 워크숍
핵심 관계자 면담형	주요 관계자 개별 면담을 중심으로 한 검토
혼합형	위 방식을 조합

※ 사건 규모와 참여기관 수에 맞는 방식을 고릅니다.

평가회의 진행 질문 — WHO 사후검토의 흐름을 참고해 구성한 예시

순	질문	회의에서 확인할 것
1	**위기 전에 무엇이 준비되어 있었는가**	매뉴얼, 연락망, 업무조정표, 훈련 실적, 비축물자
2	**실제로 무슨 일이 있었는가**	시간순 경과와 주요 결정(의사결정 기록지 활용)
3	**무엇이 잘 작동했고, 왜 그랬는가**	계속 유지하고 다른 부서에도 퍼뜨릴 방식(우수 사례)
4	**어디에서 막혔고, 왜 그랬는가**	절차 · 시스템 · 자원의 공백(사람이 아니라)
5	**다음에는 무엇을 다르게 할 것인가**	매뉴얼 · 교육 · 훈련 · 조직 · 인력의 개선과제
6	**누가, 언제까지, 어떤 예산으로 하는가**	담당 · 기한 · 예산 — 셋 중 하나라도 비면 실행되지 않음

진행 원칙

- **'누가 잘못했나'가 아니라 '어디서 막혔나'**를 적습니다. 사람 이름을 적으면 다음부터 아무도 말하지 않습니다.
- 현장 실무자와 유관기관(의료기관 · 시설 · 소방 등)의 경험을 함께 듣습니다.
- 위기 중 작성한 의사결정 기록지 · 상황보고서 · 소통관리대장을 근거 자료로 씁니다.
- 직원 경험 공유회와 공식 인정을 평가와 함께 진행합니다 (부록 8).

고리가 끊기는 지점

경험 → 사후평가 → **개선과제 → 실행** → 교육 → 모의훈련 → 재점검

사후평가와 개선과제 도출까지는 대부분 합니다. 멈추는 곳은 **개선과제와 실행 사이**이며, 이유는 담당자 이름이 비어 있기 때문입니다.

재점검 결과는 다음 위기의 인지 역량이 됩니다.

※ 기록이 제도를 바꿉니다. 2015년 메르스 이후 「2015 메르스 백서」(2016) 발간과 감염병예방법 개정, 2020년 9월 질병관리청 승격과 권역 질병대응센터 신설로 이어졌습니다. 이번 위기의 평가보고서는 우리가 씁니다.

부록 9

사후검토(AAR) 진행 양식 (2/2) 기록 양식

개선과제마다 담당 · 기한 · 예산을 함께 적습니다.

쓰는 시점
평가회의 당일

개요

사건명		**대응 기간**	
평가회의 일시		**진행 방식**	☐ 디브리핑 ☐ 워킹그룹 ☐ 면담 ☐ 혼합
참석 기관 · 부서			

시간순 주요 결정 — 의사결정 기록지에서 옮겨 적습니다

일시	결정 · 조치	당시 근거	결과 · 평가

잘 작동한 것과 그 이유

막힌 지점과 그 이유 — 절차 · 시스템으로

개선과제 — 담당 · 기한 · 예산 중 하나라도 비면 실행되지 않습니다

번호	개선과제	막힌 지점 (절차 · 시스템)	담당 부서 · 담당자	기한	소요 예산	예산안 반영	재점검일
1						☐	
2						☐	
3						☐	
4						☐	
5						☐	

후속 반영 확인

반영 대상	담당	완료 예정일	확인
매뉴얼 · 현장조치 행동매뉴얼 개정			☐
업무조정표 환류 · 재조정(부록 4)			☐
교육 · 모의훈련 계획 반영			☐
다음 해 예산안 제출			☐
직원 회복기간 · 휴가 · 심리지원 · 공식 인정			☐

작성		**확인(보건소장)**	

근거 · 강의 88–89쪽, 92쪽(담당 부서 · 기한 · 예산) · 「2025 감염병 위기 시 보건소 업무조정 안내서」 24쪽(환류), 26쪽(업무회복) · 교육용 양식이며 기관 서식에 맞게 조정합니다.

부록 10

법령 · 지침 근거표와 참고문헌

보고 · 결재 · 의회 대응 때 근거를 바로 찾기 위한 색인입니다.

쓰는 시점
보고 · 결재 시

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 주요 조문 — 2026.10.8 시행본 기준

조문	제목	보건소장이 쓰는 장면	관련 부록
제4조	국가 및 지방자치단체의 책무	감염병 예방 · 관리 사업(교육 · 홍보 포함) 수행의 근거	2
제6조	국민의 권리와 의무	알 권리와 신속한 정보공개 의무(제2항)	6
제11조	의사 등의 신고	의료기관 신고 접수와 신고 독려	3
제13조	보건소장 등의 보고 등	신고를 받은 보건소장의 보고	3
제16조	감염병 표본감시 등	평시 감시자료 검토 체계	2
제18조	역학조사	유행 우려가 있거나 감염병 여부가 불분명할 때의 역학조사	3
제18조의5	감염병 교육(시행령 제17조)	소속 공무원 · 직원 법정 교육: 연 1 · 4 · 10시간 이상	2
제34조의2	감염병위기 시 정보공개	'주의' 이상 경보 시 이동경로 등 신속 공개, 성명 · 상세 주소 제외, 목적 달성 시 삭제	6
제41조	감염병환자등의 관리	입원치료 등 환자 관리	3 · 5
제42조	감염병에 관한 강제처분	조사 · 진찰, 격리 등 강제조치의 권한과 한계	5
제47조	감염병 유행에 대한 방역 조치	유행 시 오염 장소의 일시적 폐쇄, 출입금지, 이동제한 등	5
제49조	감염병의 예방 조치	집합 제한 등 예방 조치	5
제49조의2	감염취약계층의 보호 조치	'주의' 이상 경보 시 의료 · 방역 물품 지급 등	7

※ 2026.12.10 시행 개정분은 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 별도로 확인하십시오. 조치 권한의 주체(질병관리청장, 시 · 도지사, 시장 · 군수 · 구청장)는 조문별로 다르므로 처분 전 원문을 확인합니다.

국내 지침 · 매뉴얼

- 보건복지부 · 한국건강증진개발원, 「감염병 위기 시 보건소 업무조정 안내서」(2025 원문 대조, 2026 최신판)
- 질병관리청, 「감염병 위기 사회대응 매뉴얼 — 사회대응 수단 의사결정 및 운영 절차 안내서」(2026)
- 질병관리청, 「공중보건 위기소통 표준운영절차」
- 질병관리청, 해당 감염병 대응지침 최신판(예: 2026–2027절기 인플루엔자 관리지침)
- 보건복지부, 「2015 메르스 백서」(2016)
- 부산광역시, 주간보호시설 내 신종감염병 확진자 발생 위기대응 모의훈련 시나리오(2026)
- 「보건소 바이블」 제7장 감염병 대응 및 방역(2026.4 내부 편찬본 — 정부 공인 표준매뉴얼이 아님)

국제 자료 · 학술 문헌

- WHO, Strategic Toolkit for Assessing Risks(STAR), 2021
- WHO, Guidance for After Action Review(AAR), WHO/WHE/CPI/2019.4 · AAR Toolkits
- CDC, Crisis and Emergency Risk Communication(CERC) Manual — Introduction(2018 Update)
- CDC, Guideline for Isolation Precautions
- CDC, Guidance on PPE for Healthcare Workers Caring for Patients with VHF — trained observer
- IFRC · UNICEF · WHO, Social Stigma associated with COVID-19(2020.2.24)
- 박세윤 외, 코로나19 유행에 대응하는 의료종사자의 감염과 소진을 예방하기 위한 지침, 의료관련감염관리 2023;28(1):50-63
- Mutch CP 외, The PATH to PPE Mastery, Infect Prev Pract 2023;5(4):100308

그 밖의 법령

법령 · 조문	내용	관련 부록
지역보건법 제11조	보건소의 기능 및 업무 — 업무조정표의 사업 분류 기준	4
감염병예방법 시행령 제22조의2	감염병위기 시 공개 제외 정보(성명, 읍 · 면 · 동 단위 이하 거주지 주소 등)	6
출입국관리법 제84조 · 시행령 제92조의2	공무원의 통보의무와 면제 — 공공보건의료기관의 보건의료 활동 관련 환자 신상정보는 통보의무 면제(제2호)	7
재난 및 안전관리 기본법 제38조	위기경보의 발령 — 정보공개와 취약계층 보호 조치가 '주의' 이상 경보와 연결됨	4 · 6 · 7

권한 주체 역학조사 · 강제처분 · 방역 조치 · 예방 조치의 주체는 법에서 '질병관리청장, 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장'으로 정합니다. 처분 전에 우리 지자체의 위임 · 전결 규정과 현행 조문을 확인합니다.

참고

용어 풀이

이 핸드아웃과 지침에 자주 나오는 말을 쉬운 말로 풀었습니다. 정확한 정의는 해당 법령 · 지침을 따릅니다.

쓰는 시점
낯선 말이 나올 때

체계와 단계

국가 위기경보	감염병 재난의 위기 수준을 나라 차원에서 알리는 4단계(관심 → 주의 → 경계 → 심각). 중앙이 발령합니다.
업무조정 위기단계 (C · B · A)	위기 때 보건소의 평소 사업을 어디까지 유지할지 정하는 3단계. C가 가장 낮고 A가 가장 높으며, 보건소장이 정할 수 있습니다.
업무조정표	사업별로 C · B · A 단계에서 계속할 업무를 미리 적어 둔 표. 매년 지역보건의료계획 시행계획과 함께 작성합니다.
사회대응 수단	감염 확산을 줄이기 위해 사회 활동을 조정하는 조치. 권고 · 권고 강화 · 제한 · 금지의 4단계로 운영합니다.
감염취약시설	요양병원 · 요양시설처럼 감염에 취약한 사람이 모여 생활하거나 이용하는 시설.

역학조사

역학조사	감염병이 어디서 왔는지(감염원)와 누가 노출됐는지(접촉자)를 사람 · 시간 · 장소 · 증상으로 확인하는 조사.
잠복기	감염된 뒤 증상이 나타나기까지의 기간. 감염원을 찾을 때 씁니다.
전파가능기간	환자가 다른 사람에게 옮길 수 있는 기간. 접촉자 범위를 정할 때 씁니다.
접촉자	환자의 전파가능기간에, 해당 감염병 지침이 정한 기준으로 노출된 사람.
사례정의	누구를 환자 · 의사환자로 볼지 정한 기준. 감염병별 지침에 있습니다.
표본감시	지정된 의료기관이 정기적으로 신고한 자료로 유행 추세를 보는 감시. 모든 환자를 신고하는 전수감시와 구분합니다.

감염관리와 보호구

표준주의	감염 여부와 관계없이 모든 환자에게 적용하는 기본 감염관리(손위생, 기침예절, 환경 소독, 상황에 맞는 보호구).
전파경로별 주의	표준주의에 더해 전파 방식에 따라 추가하는 조치. 접촉주의 · 비말주의 · 공기주의가 있습니다.
코호트 격리	같은 병원체에 감염되었거나 노출된 사람을 한 구역에 모아 관리하는 격리 (동일집단격리).
음압병상	병실 안 기압을 낮춰 공기가 밖으로 새어 나가지 않게 한 격리 병상.
개인보호구(PPE)	마스크 · 장갑 · 가운 · 보호복 · 고글 등 종사자를 감염에서 보호하는 장비.
N95 밀착도 검사 · 밀착 확인	밀착도 검사는 얼굴에 맞는 제품을 고르는 검사, 밀착 확인은 착용할 때마다 새는 곳이 없는지 스스로 점검하는 것.
훈련된 관찰자	보호구를 입고 벗는 단계를 체크리스트로 읽어 주며 확인하는 사람. 고위험 감염병 대응에서 둡니다.

소통과 평가

위험소통(위기소통)	위험 상황에서 주민이 스스로를 지키는 결정을 할 수 있도록 정보를 주고받는 일.
한목소리 원칙	발표 창구를 한 사람으로 고정하고 중앙 · 시 · 도와 수치 · 메시지를 맞추는 것 (원보이스).
CERC	미국 질병통제예방센터(CDC)의 위기 · 긴급 위험소통 원칙.
STAR	세계보건기구(WHO)의 지역 위험평가 도구.
사후검토(AAR)	대응이 끝난 뒤 취한 조치를 되짚어 잘된 점과 고칠 점을 찾는 검토.

배포 · 사용 전 확인 사항

항목	확인할 내용
업무조정 단계(부록 4)	2025 안내서 원문(7 · 13–16 · 21–26쪽)과 대조했습니다. 2026판에서 문구 · 사례표가 바뀌었는지 배포본으로 확인하십시오.
법령 조문(부록 10)	2026.10.8 시행본 기준입니다. 처분 전에는 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 현행 조문과 2026.12.10 시행 개정분을 확인하십시오.
시간 · 주기 · 수치	초기 72시간 구분, 분기 · 반기 주기, 사후평가 4주는 교육적 구분 또는 기관 자체 목표입니다. 근무 · 휴식 수치는 전문가 권고 사례이며 법적 의무가 아닙니다.
감염병별 기준 · 연락처	격리 · 접촉자 범위 · 검사는 해당 감염병 지침 최신판을 따릅니다. 통역 창구 번호와 운영 내용은 배포 전에 확인하십시오.

유의 이 핸드아웃은 교육과 업무 참고를 위한 자료이며 법령과 공식 지침을 대체하지 않습니다. 실제 처분과 조치는 현행 법령과 질병관리청 · 시 · 도 지침에 따릅니다.